

산과학 썸썸썸머리

◆ 공지사항

- 이 자료는 산과를 하루 컷 하려는 용자들을 위해 제작되었습니다. (쓰일 일이 없는 것이 베스트입니다.)
- 그래서 최대한 짧은 내용으로 고효율을 뽑는 것이 목표인 자료입니다. 모든 내용을 포괄하고 있진 않으니 만점을 원한다면 썸머리나 썸썸머리를 보세요.
- 수업 중 강조점 + 다빈도 기출 + 썸부 개인의 픽을 위주로 만들었습니다.
- 낮은 적중률에 대해 썸부는 책임을 질 수 없으나, 그래도 나을만한건 다 담은 듯합니다.
- **빨간색**으로 써진 글씨는 무조건 알아야 하는 내용입니다.

#임신병의 병인병기 (18)

- ① 임신 후의 특수한 변화 (임신병 발병의 기초)
- ② 임신부 체질 소인
- ③ 임신 전후 病邪에 감촉된 상태 (임신병 발생의 결정적 요소)

#임신병의 발병기전 (19, 17, 14, 미상)

- 주로 **(血熱傷胎, 腎虛, 脾虛, 氣鬱, 氣血虛弱)** 등
- 기타 跌仆, 手術創傷, 毒物, 藥物傷胎 등으로 발생

#임신병원유삼대강 (11, 06)

一曰(陰虧) 二曰(氣滯). 三曰(痰飲)"

#임신병의 치료원칙

(治病)과 (安胎)

#안태법 4가지 (19, 18, 14, 13, 07 미상)

- ① **養血清熱**: 음혈이 胎를 양육하면 모체의 음혈이 휴허 → 혈열망형
황금이 안태의 성약(주단계 제시)
- ② **理脾安胎**: 비가 건강해야 기혈을 生.
황금과 백출(고금출탕)이 안태의 요약.
금궤요략의 임신 중 상복약: 당귀산(양혈청열건

비), 백출산(건비온중안태)

- ③ **開鬱順氣**: 태가 형성되면 모체의 기혈이 모여 태를 양육하는데, 기혈이 모이면 쉽게 울체됨.
→ 향부자로 開鬱氣, 사인 소엽 진피: 안태 처방의 주요 약물

- ④ **補腎固腎**: 補腎은 固胎의 근본이 되고 培脾는 益血의 근원
→ 백출(비), 토사자(신), 육미(壯水), 팔미(益火)

#임신 중 삼금 三禁 (10, 09, 08, 미상)

發汗 (망양傷氣), 攻下 (망음傷血), 利小便 (傷津액)

#유산의 정의

태아가 생존 가능한 시기 이전에 임신이 종결되는 것

제태연령 20주 이전, 혹은 태아가 500g 미만일 때 임신이 종결되는 것.

#자연유산의 감별진단

- ①임신 제 1삼분기에 질출혈이 있을 경우(15, 13):
자궁경부이상, 자궁외임신, 태아가 생존한 상태에서 원인불명의 출혈, 질 또는 자궁경부의 감염, 포상기태, 자연유산, 용모막하출혈, 질외상

- ②hCG 1,500mIU/mL이상이면서, 질초음파상 임신양이 보이지 않는 경우
→ 유산, 자궁외임신 의심 →자궁외임신을 배제해야 자연유산으로 진단

#자연유산의 모체측 요인 (14)

감염(연관성 불확실), 만성질환(비만, 염증성장질환, 암 자체보다는 항암치료), 내분비이상(갑상선 기능 저하증, 당뇨, 황체호르몬 결핍), 영양 결핍(관련성 불명확), 약물 및 환경 요인(흡연, 알코올, 카페인, 경구피임약), 면역학적 요인, 생식세포 노화, 모체의 수술, 해부학적 이상(선천성 자궁기형, 자궁근종, 자궁선근증, 자궁 내막 유착, 자궁 경부 무력증)

#자연유산의 분류

- ① 절박유산
임신 20주 이전에 **자궁경부의 개대없이 질출혈이**

동반되는 것.

② 불가피유산

자궁경부가 개대된 상태에서 태막파열로 된 경우.
유산이 거의 불가피

대개 자궁수축이 시작되고 임신산물이 배출되거나 감염이 발생

출혈이나 통증발열을 수반하는 액체의 배출(양수 누출)이 발생

③ 완전유산

태반이 완전히 떨어지고 임신산물과 함께 배출됨

⑤ 계류유산

배아 혹은 태아가 죽은 채로 자궁 내에 머물러있는 상태

⑥ 패혈유산

유산(자연 및 인공)에서 감염이 발생하는 경우. 자궁내막염이 가장 흔함.

⑦ 반복유산

과거 습관성 유산. 3회 이상 자연유산 되는 것

#자궁 경부 개대 방법

(Q. 자궁 경부 왜 개대 시키나요? A. 유산시킬 때 소파술 하려고요)

① 흡습성 자궁경부확장물

기구를 이용해 물리적으로 자궁경부를 확장

-라미나리아: 해초를 말려서 만든 것.

:자궁경부에 꽂아두면 자궁경부의 구성성분인 proteoglycan으로부터 수분을 흡수하여 해리 → 자궁경부가 부드러워지고 확장됨.

② 프로스타글란딘제제를 질후구개에 삽입

#유산 방법중 외과적 치료법의 합병증 (12, 08)

자궁천공, 자궁경부 무력증, 자궁 내막 유착, 중증 소모성 응고병증, 감염, 마취 합병증

#초기 임신 유산시 사용되는 약제 (17)

미페프리스톤(mifepristone): 프로게스테론(자궁수축억제)의 작용방해. (결국 자궁 수축시킨다는 뜻) 아직 한국 허용 안됨

미소프로스톨(misoprostol): (PG)자궁근육수축 유발.

메토트렉세이트Methotrexate): 영약막에 작용하여 착상 억제 (항암제의 일종)

미프진: 미페프리스톤과 미소프로스톨을 순차적으로 먹는 것 ☞ 미페프리스톤은 자궁에서 수정란을 탈락시키고, 미소프로스톨은 자궁수축을 유발하여 태아와 수태산물을 자궁 밖으로 내보내는 역할 (그래서 둘이 같이 먹는게 미프진!)

(참고: 제 2삼분기에서는 유도분만을 하는데, 이때 옥시토신을 쓴다.)

#약물을 이용한 유산의 금기증

(유산은 출혈이 매우 심할 수 있으므로)

약물 알레르기, 자궁내피임장치, 심각한 빈혈, 응고장애가 있거나 항응고제를 투여 받은 임신부에서 금기

#태동과 태루의 정의

태동(胎動): 하혈과 복통이 모두 있는 것

태루(胎漏): 하혈은 있으나 복통이 없는 것

태동과 태루는 墮胎, 小産의 전조증상으로 현대의 학의 절박유산에 해당

치로는 "胎漏宜(清熱), 胎動宜(行氣)" (14, 08, 06)

#임신 시 초음파 정상조건

(요즘 초음파가 핫하기도 하고, 이 내용 9주차에 한번, 12주차에 한번 수업했으니 잘 알아두는 것이 좋겠습니다.)

임신낭: 두꺼워진 탈락막 안에 2-3mm의 임신낭이 보임.(5주경. double ring)

난황 :임신낭 내에 난황 확인(일반적으로 MSD 5-6mm 정도일 때 난황이 관찰. MSD 8-12mm이상일 경우라면 반드시 관찰 msd=임신낭 크기)

배아 : 질초음파로 5-6주, 난황 끝부분에 부분적으로 두꺼워진 1-2mm의 작은 배아 관찰 (MSD 26mm이상이면 반드시 관찰되어야 함.) 임신 6-10주에 CRL이 매일 1mm씩 자라고 모양이 C자로 굽어짐

태아심박동: 배아 2mm 이상이 되면 대개 관찰. CRL 7mm 이상이 되면 반드시 관찰되어야 함. 대개 임신 6-6.6주에 관찰. 정상 심박수는 110-160bpm

#태동 태루의 주요방제

안태음: 병원을 모를때의 임신통치방.

: 古芩朮湯(백출, 황금) + 四物湯(補血 : 당귀, 천궁, 백작약, 숙지황) + 利氣行血(소엽, 사인, 진피) + 調和諸藥(감초)

교애사물탕

古芩朮湯(백출, 황금) + 四物湯(補血 : 당귀, 천궁, 백작약, 숙지황) + 小阿膠湯(固經止血 : 阿膠, 艾葉) + 理氣(향부자, 사인)

#태태, 소산의 정의 (07, 06)

임신 20주 이전, 체중 500g 이하에서 임신이 중단되는 경우.

조기유산=임신 12주 이전에 발생 = 태태 (배태형상 이루어지기 전)

만기유산=임신 12주-28주에 발생 = 소산 (태아형성된 후)

(참고: 활태= 반복유산에 속함.)

#자궁 내 태아사망의 정의

태아가 **생존가능한 시기에 도달한 이후에** 수태산물이 모체로부터 완전히 만출되기 전에 **사망한 것. = 사산Stillbirth**

#자궁 내 태아사망의 증상, 소견 및 진단

증상: 태동의 소실, 자궁저고의 감소, 산모의 체중 감소(확실한 근거 될 수X)

진단: **태동의 소실**을 호소하는 산모들에서 **초음파로 심박동 정지를 확인**하는 것이 가장 간단하고 정확

초음파소견: 태아 심방박동 소실, 호흡운동 정지. **보푸라기증후군**(fipping sign, 태아가 용해되어 형태가 흐트러지고 번지는 것.)에 의한 불규칙한 윤곽

(참고: 태아사망후 5주 이후에는 (태아가 안빠져나오면) 25%에서 모성합병증으로 **저섬유소원증**)

(한의학에서 자궁 내 태아사망=태사불하)

#태사불하의 변증논치(15, 14)

=태사불하의 한의학적 기전 3가지(19, 15, 06)

특이증상: 구출예취, 태후니, 하복에 침타냉감

(꿀팁: 변증논치 문제에서 입냄새 난다고 나오면 태사불하!)

치료원칙: **신속한 하태**를 위주

변증	치법	처방
氣血虛弱證	益氣養血, 活血 下台	救母丹
氣滯血瘀證(14)	活血行滯, 祛瘀 下胎	脫花煎
脾虛濕困證(15)	健脾化濕, 行氣 下台	平胃散 + 芒硝

#자궁경부무력증의 정의

임신 2삼분기에 **진통을 수반하지 않은 채로 자궁경부가 열려서**, 양막 또는 태아가 질밖으로 만출되는 질환 (반복유산의 해부학적 요인 중 하나)

정상 임신의 자궁경부

:임신30주까지는 자궁경부가 비교적 안정상태 유지, 이후 조금씩 짧아짐.

#자궁목원형결찰술 (19)

자궁 경부 무력증의 유일한 수술적 치료 (=맥도날드 수술) (자궁목을 원형으로 돌려 묶는 방법)

예방적으로는 12-16주 사이에 시행. 24주 이후에는 생존가능성이 있고 수술에 의한 이점이 적어 잘 시행하지 않음.

합병증: 자궁내 감염, 양막파열, 조기진통, 자궁경부 혹은 자궁의 열상

시행 후: 임신 36(37)주경 실을 제거한 후 자연분만을 기다림

(내과적 요법으로 안정요법, 프로게스테론, 베타길항제를 쓰기도 함 (잘 안씀))

반복유산. 활태 (=습관성유산)의 원인 (07)

- ① 원인 불명
- ② 부모의 염색체 이상 (5%)
- ③ **해부학적 요인** (12%)
- ④ 산도감염 (5%)
- ⑤ **내분비학적 원인 (08)** (17%) (고프로락틴혈증 제일 많고, 황체기 결함, 당뇨, 갑상선 질환, PCOD, 난소예비능 감소 등)
- ⑥ **면역학적 원인** (50%)
- ⑦ 다른 요인들 (10%)

예후인자: 산모의 나이/ 이전의 유산횟수/ 태아의 심박동 유무

전신 홍반성 낭창 (SLE)과 항인지질증후군 (APS)

반복유산과 관련된 대표적 질환들 (위의 ⑥의 내용)

기전: 자가항체 양성 소견 -> 이들 자가 항체들이 임신 중 탈락막 또는 태반의 혈관내피세포들을 공격하여 반복유산을 일으킴

항인지질항체(10주 이후에는 태반 미세혈관의 혈전형성)의 치료: 저용량 아스피린+ 헤파린

활태의 변증론치 (18, 17) 증상보고 치법, 처방 알 수 있게!

계! 참고로 기침은 기혈양허만 두 번 나옴

변증	증상	치법->처방
脾腎兩虛證	頭暈耳鳴 腰膝酸軟 神疲肢倦 氣短乏力	보신건비, 益精養血(익정양혈) -> 보신고충환, 가감중용토사환
氣血兩虛證	面色晄白 萎黃, 心悸氣短 頭暈肢軟 神疲乏力 舌淡 苔薄白 脈細弱無力	益氣養血, 佐以健脾 -> 泰山盤石散 (태산반석산)
陰虛內熱證	腰痠腹痛 태동불안 出血少量 兩顴潮紅 手足心熱 煩燥不寧 口乾咽燥 形體消瘦 舌紅 小苔 脈細數	養陰清熱, 涼血固衝 -> 보음전, 兩地湯(양지탕), 가감일음전

자궁외임신 발생 빈도 증가 원인 (15, 13)

진단법의 발달(소멸 가능성 있는 자궁외임신의 조기 진단), 난관 감염 및 손상, 난관수술 증가, 보조생식술의 시술 증가, IUD(자궁내 피임기구) 사용, 흡연, 자궁내막증 등

-> 진단법의 발달 제외하고는 '자궁외임신의 원인 및 위험인자'에도 해당하는 내용!

자궁외 임신의 진단

① 3대 임상증상: 월경의 지연, 불규칙한 질출혈, 하복부 통증

감별해야할 질환: 골반 염증성질환, 절박 유산, 난소 낭종의 염전(꼬임), 급성 충수돌기염, 위장관 장애, 자궁내장치, 비정상자궁출혈, UTI(요로감염), 불완전유산 (11, 08, 07, 06)

② 초음파 검사: 자궁강내 체액의 저류로 위임신낭(double ring sign 유무로 구별)

③ 식별범위

:정상임신이라면 반드시 질식 초음파로 임신낭의 확인이 가능한 β -hCG 수치.

보통 1500-2000 mIU/mL

-> 식별범위 이상의 수치이면서/ 초음파상 임신낭 안보이면 생존불가능한 임신

-> 식별범위 이하이면서, 임신소견 안보이면

다음과 같은 경우를 고려할 수 있음 (19, 17)

-초음파 검사에 나타나기에는 너무 이른 정상임신

-비정상 자궁강내임신 -최근 유산

-자궁외임신 -임신이 아닌 경우

자궁외 임신의 치료

① 수술적 치료: 난관절제술, 난관개구술

② 내과적 치료: Methotrexate(MTX). 엽산길항제로 DNA 합성을 억제.

③ 기대요법: β -hCG 농도가 매우 낮고 감소하고 있는 무증상의 경우에만 제한적으로 사용

한의학: 자궁외임신은 소복혈어의 실증 -> 활혈, 화어, 消癥

자궁내 성장제한 (IUGR)

출생체중이 해당 임신주수의 10백분위수 미만.

(->인종이나 국가에 맞는 기준 필요)

가장 많은 원인은 임신중독증

신생아 가사, 폐렴, 폐혈증, 심부전, 혈소판 감소증 등 초래

자궁내 성장제한 (IUGR)의 분류

① 대칭형: 전체적으로 신체가 작다.(비율은 괜찮) 임신 초기 세포수 증가에 이상. 두위HC/복위AC 비율 낮음

=형성부전형(주로 태아측 원인. 염색체 이상)

② 비대칭형: 머리와 신장에 비해 체간 가늘고 마름. 두위/복위 큼. 세포 크기 증가에 이상. 전자간증 태반부전증 등 임신후기 손상 시 발생

=위축형(모성요인 또는 자궁태반순환부전에 의함)

IUGR의 처치

임신 주수와 양소과소증 동반 여부 고려해서 분만시기 결정

34주 이후, 양수과소증 동반된 경우 즉시 분만

34주 이전, 양수량 정상인 경우 폐성숙 기대하며 경과관찰

(참고: 저용량 아스피린으로 IUGR 예방가능)

태위부장

한의학에서는 자궁내성장제한을 태위부장이라고 한다

① 병인병기: 허, 한, 열, 혈어

② 변증논치

임상증상: 자궁고 낮지만, 태동존재, 복부증대 현저하지 X / 치료: 調理氣血을 위주로

변증 논치	증상	치법	방제 예시
氣血 虛弱 證	面色萎黃, 晄白, 頭暈心悸, 脣舌 淡	益氣養血, 滋養胎元	八珍湯, 黃芪散
血寒 證	形寒怕冷, 四肢 不溫	溫陽散寒 養血育胎	長胎白朮 散 溫土毓麟 湯
血熱 證	面赤脣紅, 煩燥 口乾, 舌紅苔黃	清熱涼血 養陰安胎	涼胎飲 保陰煎

양수량

양수량은 임신34~36주까지 증가하다가 이후 감소
태아의 소변생성(양수생성)과 태아삼킴(양수흡수)
은 양수량 변화의 주요 요인

초음파를 사용한 양수측정법

① 단일최대양수포켓측정 (MVP)

가장 깊은 하나의 양수포켓을 찾아 깊이 측정
정상범위 2~8cm

② 양수지수 (AFI) 측정 (15, 13, 07, 미상)

자궁을 4부분으로 나누어 가장 깊은 곳의 수직깊
이를 측정한 후 모두 합함 (가장 많이 사용)

정상범위 5~24cm

->정상범위 벗어나면 양수과소증 or 과다증으로
진단

양수과다증의 원인 (12)

65%는 원인불명

태아기형: 특히 중추신경계, 위장관계 기형

-식도폐쇄증, 입술갈림증 등 양수 못 마시는 경우

-무뇌증, 척추갈림증 등 노출된 신경조직으로부터
삼출액 유출

임산부 당뇨, 기타(다태임신, 태아적혈모구증)

양수과다증의 진단

증상(12): 주수에 비해 큰 자궁. 태아 잘 안 만져
짐. 피부가 팽팽하여 빛남, 산모의 호흡곤란, 부종,
소변감소증/ 합병증으로 조기양막파열

감별진단: 복수, 다태임신, 큰난소낭종과 감별(복
부팽대가 나타나는 다른 질환들)

양수과다증의 처치

이뇨제 투여, 수분,염분 제한은 효과 X

양수천자술: 합병증으로 양막파열 위험

인도메타신: 강력한 PG 합성효소 억제제. 폐에서
양수생성 억제, 소변 생성량 감소, but 태아 동맥
관 조기 폐쇄 시킬 위험(동맥관개존증에도 쓰는 약)

한의학: 건비이수, 양혈안태 -> 이어탕, 신착탕

양수과소증의 원인

과속임신, 조기양막파수, 비뇨생식기선천기형(소변
못 만들어서) 태아발육제한, 모체의 만성고혈압, 당
뇨, 혈액량 감소나 탈수, 인도메타신
3삼분기의 50%는 원인불명

양수과소증이 태아에게 미치는 영향 (15, 13, 07)

태아의 변형(양막과의 유착, 압박으로 인함), 제대
압박, 태아사망 등이 발생

potter 증후군: 폐형성부전증과 얼굴, 사지의 기형
이 동반

태위부정 = 비정상 태위 (주로 둔위)

원인: 미숙아, 양수과도 및 과소증, 태아기형, 다산
에 의한 자궁이완, 자궁의 과도팽창, 자궁기형 등

분만방법: 제왕절개 실시 (질식분만하면 저산소증,
자궁파열, 제대탈출 등 초래)

외부전위법=태아외회전술:(밖에서 손으로 태아 돌리는
것) 37주에 진통 전에 시행.(그 이전엔 알아서 돌거나
다시 돌 수 있음) 전치태반, 다태임신시 금기, 양수과
소증, 제대 목감김 있을 때 상대적 금기.

한의학에서 발병기전: 간울기체(소요산), 기혈허약
(팔진탕), 신음허(육미지황탕)

임신오조, 입덧

중증도의 구역 및 구토는 대략 임신 16주까지.

hCG와 estrogen 상승과 관련

쿠바드 증후군: 남자입덧(환상임신증상)

임신구토의 특징: 새벽이나 오후 3시경 공복에,
음식물이 섞이지 않은 점액상 액체.

한방에서 임신오조

① 발병기전: 충맥의 기가 상역하고 위가 하강작용을 실조하여 발생

② 변증논치 (14, 06, 미상) **밀중이 기충**

脾胃 虛弱 證	口苦하고 嘔吐 清涎 口淡乏力 神疲思睡	健胃 和胃 降逆 止嘔	향사육군자탕, 보생탕
위 한 허 한 을 겸	口淡하고 畏寒하며 泛惡口吐清水	온중산 한으로 사	건강인삼반하한
肝胃 不和 證	口苦咽乾하고 酸水나 苦水を 구토 흥만협통, 噯氣 大息, 頭暈頭瘡 煩熱口苦	調肝 養胃 降逆 止嘔	소엽황련탕 + 반하, 진피, 죽여, 오매 굴피죽여탕 + 황련, 오매
痰濕 阻滯 證	胸脘滿悶 嘔吐 痰涎 口中淡膩 심계기단	豁痰 降逆 止嘔	소반하가복령 탕 + 백출, 사인, 진피
氣陰 兩虧 證	구토극렬 血性 嘔吐 발열구갈 뇨소변비 精神危慌 形體 消瘦 兩目無神 眼眶下陷 피부 건조	益氣 養陰 和胃 止嘔	생맥산+ 증액 탕 만성화: 석곡, 옥죽, 량강, 복자석

③ 치료 (08, 07, 미상)

치료원칙: 調氣和中, 강역지구

+음식조절과 정지 화평

(양방치료: 안정, 수액 공급, 항오심제, 진토제)

임신 중 위궤양에 잘 걸리지 않는 이유(12)

임신 중에는 위산 분비가 감소하고, 위 운동이 감소하며 점액 분비가 증가하기 때문.

임신 중 변비가 나타나는 이유

기계적 요인+ 황체호르몬 증가로 평활근 수축 저하 -> 소장 운동성 저하 (-> 소장 음식물 통과시간 지연)

대장의 근육이완, 대장 내용물 정체 기간 증가

-> 수분 나트륨 흡수 증가

임신하리

임신설사와 차이점: 적백농혈, 이급후중

변증: 습열증(백두옹탕), 허한증(이중환)

치료원칙: 이습안태를 위주

임신 중 충수염 진단이 어려운 이유 (11)

식욕감퇴, 구역, 구토 등은 정상 임신에서 흔히 수반되는 증상.

자궁이 커지면서 충수의 위치가 점차 상,외측으로 이동하여 후반에는 옆구리 쪽에 위치하게 됨.

(참고: 임신중 충수돌기는 비임신시보다 장간막에서 떨어져 있어 파열시 복막염으로 진행이 빠름)
조기진통, 신우염, 신장경련통, 태반조기박리, 자궁근종의 이차변병 등과 혼동

임신 특수성으로 발생한 간질환의 종류 (08)

임신오조증과 동반된 간기능 장애, 간내 담즙 정체, 임신성 급성지방간, 중증 자간전증에 의한 간세포 손상

B형 간염의 수직감염 예방 (12, 06)

HBs 항원 양성인 산모로부터 출생한 신생아는 12시간내 면역글로불린 및 간염예방접종을 시작하여 3차례의 예방접종을 실시하면 주산기 감염의 80%를 예방. -> 이 경우 모유수유 허용

임신 중 고혈압성 질환의 분류

① 임신성 고혈압

임신 20주 이후 처음 고혈압 발생. 분만 후 12주 이내 정상으로 돌아옴. 단백뇨X

② 만성 고혈압

임신 이전부터 또는 임신 20주 이전부터 고혈압 있었던 경우, 분만 12주 이후에도 지속

③ 자간전증

임신성 고혈압+단백뇨 또는 (혈소판 감소증, 간기능 저하, 신기능 악화, 두통, 시야장애 또는 경련, 폐부종) 중 하나 이상 동반

④ 자간증

자간전증+ 원인을 찾을 수 없는 경련이 발생

⑤ 중복지간전증

만성 고혈압+ 단백뇨가 새로 나타나거나/고혈압이나 단백뇨 악화되거나/간수치 악화, 혈소판감소증, 신기능의 악화 등이 동반된 경우

임신 중 고혈압성 질환의 병태생리 (06)

전신적인 혈관경련 (혈관수축, 혈관손상)+ 혈관수축제(안지오텐신II)에 대한 혈관민감도의 상승

제시된 자간전증의 병인 및 기전

면역학적 요인(태아 항원에 대한 면역반응)
유전학적 요인
트롬복산 A2와 프로스타사이클린의 불균형
산화 스트레스
혈관생성인자의 불균형 / 태반형성장애

자간전증의 원인 (14, 12)

- ① 세포영양막세포가 나선동맥 (평활근 및 내피세포)에 쉽게 침투하지 못함
- ② 내피세포의 기능부전
각 장기로의 혈류량 감소가 자간전증의 뚜렷한 병태생리적 변화 -> **다발성 장기손상**

자간전증, 자간증의 한방 발병기전 (14, 11, 02)

음혈 부족 -> 간음손상, 간양상항 -> 비허간왕 음허간왕 -> 자간전증 -> 더 심해져서 간풍내동, 담화상요 -> 자간증
음혈 부족이 본, 풍, 화, 담, 어는 표

자간전증의 병리 (08)

- ① 심혈관계
자간전증에서 BP 상승의 주요 기전은 말초혈관저항의 증가. (정상임신에서는 저항 감소로 임신 전반기 혈압 낮아짐.) 혈소판 감소, 경미한 혈관 내 혈액응고 소견 (혈액응고인자의 변화)

②신장

신혈류량, 사구체여과율 감소.
중증에서 s-creatinine 증가
요산증가, 단백뇨, 소변감소증, 신기능부전

③간

AST, ALT, ALP 증가.
간 문맥주위 출혈과 이를 동반한 간경색
심한 경우 출혈로 인한 간파열과 피막하 혈종 -> **상복부통**
HELLP 증후군: 용혈, 간효소증가, 혈소판감소

④중추신경계

두통(발작의 전구증상), 시각장애, 뇌동맥 파열로 대량출혈, 대뇌부종

⑤자궁

태반 관류저하(나선세동맥 평균직경 감소)

자간전증의 예측과 예방

Roll-over test: 임신 28-32주에 실시. 옆으로 누워 있다가 바로 누워 혈압을 재어 20이상 증가하면 양성 -> 임신성 고혈압 발생확률 높음
저용량 아스피린이 효과

자간전증의 처치

입원치료가 원칙. **두통, 시각장애, 상복부통 (17, 18)**은 발작이 임박한 증세이며 핏뇨, 급격한 체중 증가도 불길한 징후.(매일 점검). 절대 안정. 염분과 수분은 특별히 제한 필요 없음. 분만이 전자간증의 근본 치료. 중증에서는 항경련제(황산 마그네슘)와 항고혈압제 투여.

자간전증, 자간증의 변증논치

위에 두 개가 자간전증(12), 밑에 두 개가 자간증

변증명	증상	치법	처방
陰虛肝旺	임신중만기 두훈목현 두통두창 이명요산 구고인건 변조불안 手指發麻 뇨소변비 舌紅有裂紋 脈弦滑數	滋陰養血平肝潛陽	기국지황환합二至丸
脾虛肝旺 (19)	임신중만기 면목지체부종 두통두현 頭痛頭麻 胸悶泛惡 嘔吐不食 神疲乏力 大便不調 舌淡 脾 脈緩滑 或 眩滑	健脾行水平肝潛陽	全生白朮散 육군자탕
간풍내동	임신후기 或正值分娩時 或산후 1~2일 두훈두통 神物不清, 변조불안, 안면홍조 돌반적인 全身抽搐 牙關緊急 甚則昏不知人 舌紅或絳 苔薄黃 脈弦滑數	平肝熄風止瘳	영양구등탕 천마구등음
담화상요	임신만기 或産時 或新産後 두훈두증 胸悶泛惡 氣逆不順 全身抽搐 口噤 昏不知人 氣粗痰鳴 舌紅 胎黃膩 脈弦滑	清熱豁痰開竅止瘳	우황청심환 안궁우황환

임신현훈의 변증논치 (13)

변증	근거	치법	처방
기혈허약	① 기혈허약 병력 ② 돌연 頭暈眼花 하고 便刻便止 ③ 心悸疲倦을 겸 舌 淡嫩 脈細弱	補 氣 升陽 養 血 益陰	팔물탕 + 황기 하 수 오 조구등 귀 비 환 검복
간양상항	① 간신음허 병력 ② 돌연 頭暈目眩 ③ 口乾苦 面赤 舌紅 脈弦細數	育 陰 潛陽	기국지황환 + 석결 명, 귀관, 구등
痰濁 壅盛	① 비신양허 병력 ② 현훈이 발생 ③ 泛惡吐涎, 口淡 納呆, 舌淡 苔白 脈緩滑	化 濕 祛痰	반하백출 천마탕 + 구 등, 단삼

임신부종의 변증논치

변증명	증상	치법	처방
脾虛 (11)	面目四肢浮腫 皮膚發亮 氣短嫩言 納少便溏	健脾 行水	전씨백출산 + 황기, 백편두, 사인 사군자탕 + 차전자, 통초, 이어탕
腎虛	面浮肢腫 하고 하지가 더욱 심하며 腰痠肢冷	溫腎 化氣 行水	신기환 진무탕 + 육계, 황기, 택사
氣滯	面浮肢腫 皮厚色不變 胸悶脇脹 氣逆不安	理氣 行滯 除濕 消腫	천산등탕 천기정향탕

임신해수의 변증논치 (07)

변증명	병기	증상	처방
음허폐조	음허 심해져 허열 내번	건해무담, 구건인조	백합고금탕
외감풍한		외감증	행소산, 길경 탕, 삼소음
비허담음	습담	해수량다, 색백조점, 신피납매	육군자탕 + 길경, 자완

임신천식의 약물치료

대부분의 치료약은 임신 중에 사용해도 안전하고 모유수유의 금기가 아니나, 드물게 theophylline이 신생아에게 지터(흔들림), 심부정맥 등 독성

임신천식의 변증논치 (19, 08)

외감풍한이랑 폐기허약도 있는데 안 나온 것 같아서 뺐습니다.

변증명	증후	치법	처방
화동기역	담천기급, 夜臥不安, 발열번조	청열평천 안태	쥬향탕
혈어조체 (19)	복만천민, 식욕부진, 태동정지, 심음소실, 얼굴 청암	활혈행기, 거어하태	탈화전 +도인

임신감기의 대표처방

소시호탕: =삼금탕. 화해의 치법

궁소산: 두통, 열 있을 때. 통치방

자완탕: 기침 심할 때

임신성 비염 (07)

임신비염=호르몬비염=혈관운동성비염

다른 호흡기계 감염 및 알레르기와 상관없는 비출혈이 6주이상 지속되고, 분만 2주 이내 소실. 임신2삼분기에 절정.

임신 중 (생리적 변화와 구분되어) 심장 질환을 의심할 수 있는 증상 또는 진찰소견

① 증상(symptom): 심한 호흡곤란, 진행성 기좌호흡, 객혈, 협심증, 운동 후의 실신, 흉부통증

②진찰소견(sign): 청색증, 곤봉증, 크게 들리는 수축기 잡음 또는 이완기 잡음, 지속적 S2분열, 흉골 옆 용기가 있는 심장비대, 지속적인 경정맥 확장, 지속적 빈맥 혹은 부정맥, marfan 증후군의 용모

심혈관계 질환에 대한 NYHA의 분류

New York Heart Association

Class 1	위태롭지 않은 형(uncompromised) 물리적 활동에 제약X. 일상생활에도 증상X
Class 2	약간위태로운형(lightly compromised) 물리적 활동에 제약. 안정 시 편함. 일

	반적 활동에 과도한 피로, 심계항진, 호흡곤란, 협심증 등의 불편함 현저히 위태로운 형 (markedly compromised)
Class 3	물리적 활동이 현저히 제한. 안정 시 편함. 일상 활동보다 미약한 활동에도 불편함
Class 4	severely compromised 심부전 증세나 협심증 증세가 안정시에 교차로. 가만히 있어도 증상.

심혈관계 질환의 관리

Class 1,2는 대부분 문제가 발생하지 않으나 심부전 예방 및 조기 발견이 중요

Class 3,4는 임신유지가 어려워 치료적 유산을 고려 /Class1~4 모두 출산 시 **질식불만**(제왕은 위험)

임신 심번 =자번

煩悶不安하고 鬱鬱不樂하고 심하면 心驚膽怯하고 煩燥易怒. 원인은 음허(가장 많음), 담화, 간울

요로감염

임신 중 가장 흔한 내과적 합병증

(참고: 요로결석은 요관이 넓어져서 드문 합병증)
상부 요로감염: 급성 신우신염, 신장 농양 (발열)
하부 요로감염: 급성 방광염, 요도염 (발열X)
장내 세균 E. coli가 가장 많은 원인

무증상 세균뇨의 미처치시 예후는? (18, 17)

75%는 무증상 상태로 지속되나, 미치료시 25~30%에서 급성 방광염 또는 신우신염으로 진행하여 조기진통의 원인이 되므로 반드시 치료.

#급성 신우신염이 임신 중 빈도가 증가하는 원인

- ① 커진 자궁에 의해 요관이 압박 -> 정체가 일어나 신장 감염에 이환되기 쉬움
- ② 산욕기 초기에 방광 감수성 감소 (출산 시 마취, 회음부 절개, 파열 등으로 인한)

동의보감의 임신소변불통(=전포증) 치료법 (11)

삼출음 먹고 토하기 / 총백 핫팩
산파가 산문에 손 넣어서 태아 약간 올려주기(거태자궁복위법과 비슷) /물구나무 서기

이게 뭔가 싶지만 교수님이 설명할 때 좋아하셨습니다..

임신 시 모발의 변화 (08, 07)

임신중: estrogen(성장기 연장)과 androgen(모낭 확대)의 영향으로 성장기가 휴지기에 비해 증가
산후: 비율이 반전되어 휴지기가 증가해 탈모가 많아짐. 산후 1~5개월 지속.

임신 중 특징적인 피부질환 (14, 12)

(Ambros-Rudolph의 분류)

① 임신성 간내담즙정체 ICP = 임신 소양증

황달 있는 경우와 없는 경우 있음.

주로 3삼분기 시작해 밤에 심함.

일차적 피부병변은 없고 굵은 상처로 인한 경미한 박리나 결절성 양진이 2차로 나타남.

다음 임신 시 재발

② 임신 소양성 두드러기성 구진과 발진 PUPPP

가장 흔함. 초산부에, 3삼분기에 흔함.

심한 소양감. 1-2mm 크기의 홍반성 구진과 판이 복부에서 엉덩이, 대퇴, 사지로 퍼짐. **얼굴, 손발바닥은 잘 침범하지 않음.**

6주 이내 소실. 다음 임신 시 재발은 잘 없다.

③ 임신 유사 천포창 = 임신 헤르페스

이름과 달리 헤르페스 virus에 의한 것이 아니고 자가면역매개 수포성 질환

다음 임신 시 재발.

④ 임신 아토피 발진 (AEP)

아래 3질환을 포함하는 포괄적 명칭

-임신 중 습진: 아토피 과거력과 밀접한 관련, 혈청 IgE가 증가

-임신 가려움발진 (=임신구진성발진): 5-10mm 크기의 홍반구진과 결절이 사지의 신전 부위나 몸통에 발생

-임신 소양성 모낭염(=포진상농가진): 매우 드문 무균성 고름 물질 발진.

임신 신양의 변증논치 (13)

혈허증 (06)	피부 건조, 진이 담홍색. 심계정충, 번조실면, 설담 태백 맥세활현	양 혈 거풍 자 양 간신	당 귀 음자 +이지환 당 귀 보혈 탕+ 형개, 오매, 감초
----------	---------------------------------------	---------------	----------------------------------

풍열증 (17, 12, 11)	진색홍, 작열, 인후종통, 두통, 설홍, 태황, 맥부활삭	소풍청열, 양혈안태	소풍산-목통, 석고+상엽용골 모려
영위불조증	충임허손. 복부, 대퇴내측, 요저부 소양감. 요산, 야뇨증 겸. 설담암, 태백 맥세활	조보충임	사물탕 + 이산탕

임신이 간질(=뇌전증)에 미치는 영향

임신 중 구토, 사구체여과율 증가로 인해 약물 배설 증가/ 태아 걱정으로 약 잘 안 먹음

-> 경련 위험 증가

(항간질제는 태아 신경관결손증을 유발할 수 있음. 특히 valproic acid. 예방 위해 엽산 먹어야)

임신과 류마티스 관절염

임신 중 RA환자 80~90%가 증상 호전, 분만 후 3개월 이내 증상 악화를 경험

임신 시 빈혈의 가장 흔한 원인 2가지

- ①철결핍성 빈혈: 임신 시 철분 요구량 증가
- ②급성 출혈

임신성 당뇨병

임신 말기에 발생. (임신 1기에 발생하면 주로 당뇨병 임신 원래 당뇨병인 사람이 임신한 것)

기전: 임신 중 인슐린 민감도 하락 + 호르몬 영향으로 인슐린 저항성 증가

선별검사: 우리나라는 중증도 위험군에 속하므로 모든 임신부를 대상으로 선별검사.(24-28주 사이에 50g 경구 당부하 검사-> 140이상이면 양성)

당뇨병이 태아에게 미치는 영향

거대아 발생 확률 높아짐, 장기적 과체중
자궁 내 태아 사망 확률 증가, 태아 기형
신생아 이환: 저혈당증, 고빌리루빈 혈증, 저칼슘증, 적혈구 증가증, 심비후 등이 증가
당 조절 잘 안되면 신생아 호흡증후군 RDS증가

당뇨병 임신 치료

인슐린(태반 통과X), 인슐린 유사체 치료
경구혈당강하제 biguanide (metformin)은 임신 중 사용 가능

갑상선 항진증

임신에 의한 대사 증가나 임신오조에 의한 일시적 갑상선과 구별 어려움

진단: TSH 저하와 free T4상승

임신에 미치는 영향: 심부전과 갑상샘 중독발작, 자간전증, 조산 위험 증가

태아에 미치는 영향: 갑상선 자극항체가 태반 통과시 태아 갑상 발생 가능.

약물치료: 비임신중에는 티오나마이드 계열, 임신중에는 PTU가 더 선호

시한 증후군 (Sheehan 증후군) (19중간)

산과적 출혈의 결과로 발생한 뇌하수체의 허혈이나 괴사상태.

급성: 저혈압, 빈맥, 저혈당, 모유생산불가

만성: 액모 및 치모 탈락, 무월경

선천성 풍진 증후군

풍진 바이러스는 태반을 통과. 특히 임신 초기에는 태아기형 유발과 관련.

합병증: 청력소실(가장 흔함), 눈의 이상(백내장, 녹내장), 심장병(동맥관 개존증, 폐동맥 협착), 중추신경계 이상(소두증, 발달지연) 등

수두-대상 포진

DNA 헤르페스 바이러스로 수두는 일차 감염이고, 신경절에 잠복해 있다가 재발해 대상포진 증세 발현

임신 중 수두 환자에게 노출된 경우: 면역 없으면 VZIG 투여.

선천성 수두 증후군: 수두 바이러스는 태반 통과. 사지형성 부전증, 피부 위축성 병변, 뇌피질 위축, 맥락망막염, 소안구증, 수신증 등.

풍진, 수두, 인플루엔자 예방접종 (17, 20중간)

①풍진: 임신 전 면역여부 검사 후 IgG 항체 없으면 임신 전 예방 접종 -> 1달간 피임. 수유기 땀 접종 가능.

②수두: 생백신이므로 임신 중 접종 금기

③인플루엔자: 모든 임신부에게 예방접종 권장. 특히 10-11월 사이 접종이 감염 최소화. 사백신으로 모유수유 중 가능.

산과적 출혈의 분류

- ① 산전 출혈: 태반조기박리, 전치태반, 전치혈관

② 산후출혈(10): 분만 3기출혈, 자궁이완출혈, 잔류태반, 유착 감입 침투태반 등

태반조기박리

태아 만출 이전 태반이 착상 부위에서 분리되는 현상

급성 복통, 질출혈, 자궁압통이 주요 임상소견.

합병증: 저혈량 쇼크, 신부전증, 소모성 혈액응고장애, 자궁태반졸증(누출된 혈액이 퍼져서 자궁이 붉거나 파랗게 보임), 시한씨증후군

전치태반

태반이 자궁경부의 내구에 매우 근접해 있거나 덮고 있음.

자연소실: 영양공급이 원활해진 자궁기저부를 향해 태반이 자람(영양주향성) + 임신 후반 자궁하절부가 팽창 -> 결과적으로 태반과 자궁 내구의 거리가 멀어짐

임상증상: 통증 없는 출혈. 주로 임신2분기 후반